

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/361087491>

# ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NO MANEJO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Article · June 2022

DOI: 10.56083/RCV2N3-045

CITATION

1

READS

197

3 authors, including:



[Umberto Marinho de Lima Júnior](#)

12 PUBLICATIONS 3 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



[Milena Nunes Alves de Sousa](#)

Centro Universitário de Patos-PB

697 PUBLICATIONS 783 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Article Fatores ergonômicos, psicossociais e riscos no trabalho na mineração informal [View project](#)



ESTRESSE E FADIGA ENTRE TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA [View project](#)



**Contemporânea**

*Contemporary Journal*

2(3): 46-68, 2022

ISSN: 2447-0961

**Artigo**

## **ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NO MANEJO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**

### **MULTIPROFESSIONAL ACTION IN THE MANAGEMENT OF AUTISTIC SPECTRUM DISORDER**

DOI: 10.56083/RCV2N3-045

Recebimento do original: 02/04/2022

Aceitação para publicação: 02/05/2022

**Heloisa da Silva Araujo**

Acadêmica de Medicina pela Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

Instituição: Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

heloaraujo1618@gmail.com

**Umberto Marinho de Lima Júnior**

Mestre em Saúde Pública

**Milena Nunes Alves de Sousa**

Pós-Doutora em Promoção de Saúde

Pós-Doutora em Sistemas Agroindustriais

**RESUMO:** O transtorno do espectro autista (TEA) é uma alteração neurológica cognitiva-comportamental possuindo uma clínica variada. Geralmente surge nos primeiros anos de vida e causa alterações na comunicação, na interação social e no comportamento. A falta de troca de olhares, do sorriso social, a preferência por objetos e atividades repetitivas além de dificuldade na fala são manifestações clínicas que variam conforme o fenótipo do paciente. Objetivou-se evidenciar a importância da atuação multiprofissional para o diagnóstico e terapêutica de crianças com transtorno do espectro autista. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativa, com buscas na Biblioteca Virtual em Saúde e Scientific Electronic Library Online. O estudo traz informações coletadas em 18 publicações científicas que abordam o transtorno do espectro autista e como ocorre o manejo dessa condição por diferentes profissionais. A abordagem multidisciplinar tem resultados positivos no prognóstico e tratamento precoce de crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista



contribuindo com o desenvolvimento cognitivo-comportamental e social. A atuação de uma equipe multidisciplinar contribui para melhoria na qualidade de vida de crianças autistas possibilitando o neurodesenvolvimento, socialização e autonomia.

**Palavras-Chave:** Transtorno do Espectro Autista, Diagnóstico, Pesquisa Interdisciplinar.

**ABSTRACT:** Autism spectrum disorder (ASD) is a neurological cognitive-behavioral disorder with a varied clinical course. It usually appears in the first years of life and causes alterations in communication, social interaction, and behavior. The lack of eye contact, social smile, preference for objects and repetitive activities, and difficulty in speech are clinical manifestations that vary according to the phenotype of the patient. The objective was to highlight the importance of multiprofessional work for the diagnosis and treatment of children with autistic spectrum disorder. An integrative review of literature was carried out with a qualitative approach, with searches in the Virtual Health Library and Scientific Electronic Library Online. The study brings information collected from 18 scientific publications that address the autistic spectrum disorder and how this condition is managed by different professionals. The multidisciplinary approach has positive results in the prognosis and early treatment of children with autistic spectrum disorder contributing to the cognitive-behavioral and social development. The performance of a multidisciplinary team contributes to improving the quality of life of autistic children, enabling neurodevelopment, socialization and autonomy.

**Keywords:** Autistic Spectrum Disorder, Diagnosis, Interdisciplinary Research.



## 1. Introdução

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma condição que afeta o neurodesenvolvimento com uma heterogeneidade clínica, tendo maior incidência nos primeiros anos de vida, se apresentando clinicamente a partir de sintomas mais centrais como: alterações na comunicação (verbal ou não



verbal), interação social e comportamental, seja através de comportamentos repetitivos ou interesses restritos (ORO *et al.*, 2012; GOMES *et al.*, 2015). Sua denominação refere-se à uma parte dos transtornos globais (ou invasivos) do desenvolvimento (TGD): o autismo, a síndrome de Asperger e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação (não inclui a Síndrome de Rett e o transtorno desintegrativo da infância) (MINISTÉRIO DA SAÚDE –MS, 2020).

Dentre os principais déficits, a pouca atenção direcionada às pessoas, a falta de troca de olhares, sorriso social e gestos são fatores que dificultam a comunicação não verbal da criança com o meio. Quanto ao desenvolvimento da linguagem, as crianças com TEA podem ter uma ausência ou atraso da fala, dificultando ainda mais a interação social dessas crianças. A resistência em alterar a rotina e introduzir novos hábitos são alterações observadas no comportamento dessas crianças, que tendem a se interessarem mais por atividades com objetos e a realização dessas de forma repetitiva (FONSECA *et al.*, 2021). É possível também identificar falhas na coordenação motora global gerando atrasos na aquisição de habilidades motoras. (CORRÊA *et al.*, 2020).

Os sintomas começam a surgir antes dos três anos de idade e podem se manifestar das mais variadas formas, apresentando respostas próprias a estímulos sensoriais, resistência a dor, hipersensibilidade ao toque, baixa habilidade interpessoal com outras crianças e até mesmo com seus cuidadores (NASCIMENTO *et al.*, 2018).

Essas crianças podem apresentar características como falta de concentração, dificuldade de aprendizado pelos métodos convencionais (VILAR *et al.*, 2019). Para tais autores, empobrecimento do controle do olhar, no processamento de emoções, da capacidade de imitação, assim como dificuldades de usar a ironia, metáfora e de reconhecimento dos seus sentimentos, pensamentos e prejuízos nas interações sociais.



Apesar de ser definido por estes sintomas principais, o fenótipo desses pacientes pode variar muito, desde indivíduos que tenham deficiência intelectual grave e desempenho em habilidades comportamentais muito prejudicado, até crianças com coeficiente intelectual (QI) normal. Além disso, crianças com TEA podem apresentar várias outras comorbidades como, hiperatividade, distúrbios do sono, epilepsia (ARAÚJO *et al.*, 2019) problemas gastrointestinais, compulsões, instabilidade no humor, entre outros (SINISCALCO *et al.*, 2018).

Sua etiologia ainda precisa ser mais estudada, porém sabe-se que há caráter multifatorial, sendo estes genéticos, sociais e neurológicos. Existem fatores de risco que contribuem para sua incidência como infecções e uso de determinadas substâncias na gestação, diabetes gestacional, história familiar de síndromes como a Síndrome de Down, de Rett, do X frágil, entre outras. Estima-se que de pelo menos 50% dos casos sejam hereditários, demonstrando que fatores genéticos são relevantes na patogênese da doença, porém a maioria dos casos de TEA ainda são de natureza idiopática (ESTRADA; TAVARES, 2021).

Na quinta edição do Manual de Diagnóstico e estatístico de Transtornos mentais (DSM-V) usam-se dois critérios diagnósticos: déficits persistentes na interação social e na comunicação em múltiplos contextos; e padrões repetitivos e restritos de comportamentos interesses e atividades (COSTA *et al.*, 2021). Em crianças muito pequenas o diagnóstico clínico é mais complexo visto que apresenta instabilidade dos seus sintomas e por estar relacionado com o desenvolvimento. O diagnóstico realizado na infância condiciona a limitações importantes no funcionamento emocional e social da criança, fazendo-se necessária cada vez mais uma intervenção precoce para que haja melhora no prognóstico do quadro (HALPERN *et al.*, 2021).

No Brasil, em 2012 foi implantada a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista a fim de garantir o atendimento integral e estimular a discussão e produção científica a respeito



(VILAR *et al.*, 2019). Recentemente, o MS realizou na Caderneta da Criança a inclusão do *Checklist* M-CHAT-R/F.A e a escala de M-CHART-R usadas como triagem em crianças entre 16 a 30 meses para o TEA, a fim de facilitar a detecção dos sinais iniciais para os profissionais de saúde que a utilizam (BRASIL, 2022).

O tratamento mais indicado para o TEA é a intervenção precoce. Esta deve ser iniciada logo após suspeita/diagnóstico contando com uma equipe multidisciplinar desde o início, além das medidas farmacológicas, incluído a presença de pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, educadores físicos, entre outros profissionais que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento dessas crianças (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA – SBP, 2019).

Neste contexto, essa pesquisa tem o intuito de evidenciar a importância da atuação multiprofissional para o diagnóstico e terapêutica de crianças com transtorno do espectro autista, contribuindo com o desenvolvimento cognitivo-comportamental e social, evidenciando a necessidade da sua aplicação na assistência dada a essas crianças com o transtorno para melhorar desenvolvimento e qualidade de vida.

## **2. Métodos**

A revisão integrativa é uma abordagem metodológica ampla, que permite a utilização de estudos experimentais e não-experimentais para que ocorra uma compreensão sobre o fenômeno então analisado (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Para construção de uma revisão integrativa há uma sucessão de etapas a serem seguidas: primeiro há a identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; o estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; a identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; posteriormente





há a categorização dos estudos selecionados; a análise e interpretação dos resultados e por fim, a síntese do conhecimento (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). A questão norteadora do estudo foi: Qual a importância da atuação multiprofissional para o diagnóstico e terapêutica de crianças com transtorno do espectro autista?

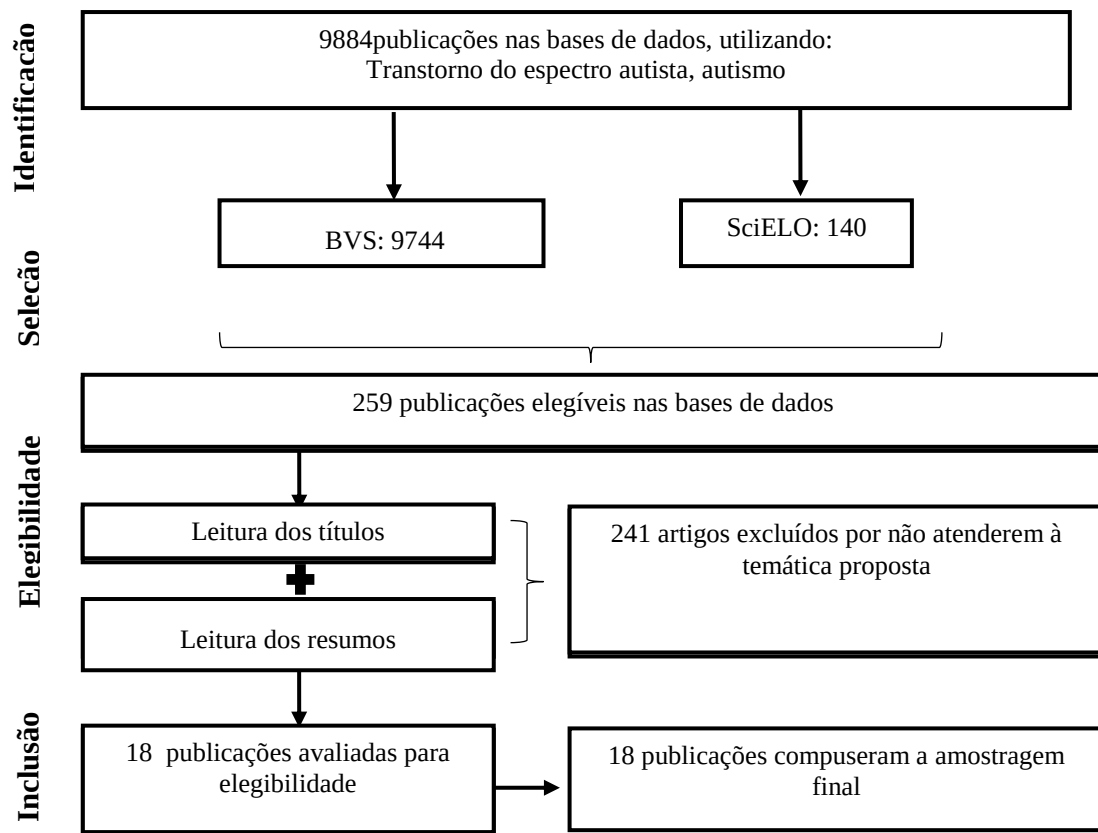
Foram realizadas buscas no Portal Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) e Base de dados de Enfermagem (BDENF).

Foram utilizados, para busca dos artigos, os descritores “Transtorno do espectro autista”, “diagnóstico” através dos descritores booleanos “AND” e “OR”. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados na íntegra em português, inglês e espanhol, que retratassem a temática proposta nos últimos 5 anos. Foram excluídos artigos incompletos, publicados em períodos anteriores ao ano de 2018, repetidos ou duplicados e aqueles que não eram pertinentes ao tema da pesquisa.

A busca inicial pelo descritor na BVS encontrou 9744 publicações. Após aplicação dos filtros foram reduzidos para 126 publicações. Na plataforma SciELO, utilizando o descritor foram encontradas 140 publicações e após utilização de filtros foram reduzidos a 133 publicações. Finalizada a etapa de coleta de dados, foram excluídos 241 trabalhos que se afastavam da abordagem proposta e aqueles que após leitura dos resumos, não contemplavam os pontos discutidos nesta revisão. A amostra final desta revisão integrativa da literatura foi constituída de 18 publicações.



Fluxograma 1: Processo de seleção dos artigos



Fonte: Autoria própria (2022)

Os dados extraídos dos estudos primários e incluídos nessa revisão foram a população do estudo, profissão, abordagem utilizada e importância da atuação. Para análise e posterior síntese dos artigos que atenderam os critérios de inclusão foram montados 3 quadros contemplando informações importantes para o estudo. O Quadro 1 foi montado com os seguintes dados: Autor, título e método. No Quadro 2, foram apresentados: população do estudo, base de dados, periódicos e país. O Quadro 3 foi montado fazendo a exposição dos seguintes dados: autor, profissão, abordagem utilizada e importância da atuação.

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi feita de forma descritiva, possibilitando o reconhecimento das profissões responsáveis pelo manejo do TEA e a importância da sua atuação.





### 3. Resultados

O estudo realizado foi composto por 18 artigos, sendo 8 encontrados na LILACS, 3 artigos provenientes da MEDLINE, 5 artigos oriundos da SciELO e 2 artigos da BDENF- Enfermagem. Em se tratando dos anos de publicações, em 2019 foi o ano em que mais houve publicações totalizando 7 artigos. No ano de 2020 foram publicados 4 artigos assim como no ano de 2021, onde foram encontradas 4 publicações e por fim no ano de 2018, totalizando a menor quantidade, fizeram parte da análise 2 publicações. Dentre os países de origem, o Brasil tem maior expressão totalizando 11 publicações. Na Argentina foram publicados 3 artigos; 1 artigo publicado no Chile, 1 na Colômbia, 1 no México e 1 publicação na Espanha (Tabela 1).

Quadro 1: Aspectos dos estudos selecionados para composição da pesquisa

| Nº | Autor (es)<br>Ano             | Título                                                                                                                                                                | Método                                                                                                                            |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Corrêa et al.<br>2020.        | Impacto do exercício físico no transtorno do espectro autista: uma revisão sistemática                                                                                | Trata-se de uma revisão sistemática voltada para a abordagem do tratamento do TEA com exercícios físicos.                         |
| 2  | Balestro; Fernandes;<br>2019  | Percepção de cuidadores de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo quanto ao perfil comunicativo de seus filhos após um programa de orientação fonoaudiológica | Foi realizada uma pesquisa com cuidadores de crianças participantes de um programa de intervenção fonoaudiológica.                |
| 3  | Alejandra; Ekaine;<br>2020    | Evidencia científica de integración sensorial como abordaje de terapia ocupacional em autismo                                                                         | Revisão da literatura sobre a evidência da terapia ocupacional aplicada no autismo.                                               |
| 4  | Fessiaet al.<br>2018          | Estrategias de actividad física planificada en autismo: revisión sistemática                                                                                          | Revisão sistemática de artigos orientados pela utilização de atividades físicas como ferramenta para melhora de crianças com TEA. |
| 5  | Rojas; Riviera; Nilo;<br>2019 | Actualización en diagnóstico e intervención temprana del Trastorno del Espectro Autista                                                                               | Revisão integrativa da literatura voltada aos avanços no diagnóstico, tratamento e intervenções no TEA utilizadas no Chile.       |



|    |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Loyanoco;<br>Ferreira;<br>Iermoli.<br>2019    | Humanismo en medicina: El rol crucial del pediatra en el trastorno del espectro autista.                                              | Revisão da literatura sobre o modelo abordado no livro de Martha Hebert, MD a respeito de pacientes no hospital pediátrico de Massachussets.                          |
| 7  | García;<br>Solovieva;<br>Rojas.<br>2020       | Evaluación e intervención Neuropsicológica en un caso de trastorno del espectro autista (TEA) severo                                  | Relato de caso sobre a intervenção neuropsicológica utilizada em um caso de TEA severo                                                                                |
| 8  | Costa et al.<br>2021                          | Influência dos métodos de ensino pecs e teacch sobre o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com transtorno do espectro autista | Foi realizada uma pesquisa observacional, longitudinal e restrospectivo de crianças submetidas aos métodos de ensino voltados ao desenvolvimento de crianças com TEA. |
| 9  | Rocha;<br>Vasques;La<br>mônica<br>(2019)      | Instrumentos de intervenção curricular para o ensino de aprendizes com o Transtorno do Espectro Autista: revisão integrativa          | Revisão integrativa da literatura que pesquisou a aplicação de instrumentos diferentes de intervenção curricular para crianças com TEA.                               |
| 10 | Magalhães<br>et al.<br>2020                   | Asistencia de enfermería al niño autista: revisión integrativa                                                                        | Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que analisou as formas de intervenção de enfermeiros no TEA.                                                        |
| 11 | Gomes;<br>Franzoni;<br>Marinho.<br>2021       | Da interação social á autonomia: vivências lúdicas no meio líquido para crianças com transtorno do espectro autista.                  | Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada através do projeto Aqua Atividades promovidos pela ONG Autonomia em SC.                                                |
| 12 | Díaz;Rodríguez;<br>Bastías<br>; 2021          | Fútbol como programa deportivo para menores con TEA en educación primaria                                                             | Pesquisa realizada em um grupo de crianças participantes de um programa de esportes com o intuito de analisar os pontos positivos do futebol no tratamento do TEA.    |
| 13 | Nascimento<br>;Bitencourt<br>; Fleig;<br>2021 | Estratégias para o transtorno do espectro autista: interação social e intervenções terapêuticas                                       | Revisão sistemática que buscou analisar estudos sobre pacientes com autismo, suas relações e as intervenções utilizadas no tratamento.                                |
| 14 | Ramírez, et<br>al.<br>2019                    | Abordaje nutricional en pacientes con parálisis cerebral, espectro autista, síndrome de Down: un enfoque integral                     | Revisão que buscou estudar a abordagem nutricional em crianças com Paralisia Cerebral, TEA e Síndrome de Down.                                                        |
| 15 | Nascimento<br>, et al.<br>2018                | Transtorno do Espectro Autista: Detecção precoce pelo enfermeiro na Estratégia Saúde da Família                                       | Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória de abordagem qualitativa com enfermeiros da cidade de Maceió, Alagoas.                                               |



|    |                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Viana, et al.<br>2020   | Práticas complementares ao transtorno do espectro autista infantil: revisão integrativa da literatura                                                   | Revisão integrativa com abordagem qualitativa que buscou analisar quais as práticas utilizadas no TEA e seus impactos no desenvolvimento das crianças. |
| 17 | Vilar, et al.<br>2019   | Transtornos autísticos e estratégias promotoras de cuidados: revisão integrativa                                                                        | Trata-se de uma revisão integrativa desenvolvida a partir das estratégias utilizadas para o manejo do TEA.                                             |
| 18 | Torras;<br>Más;<br>2019 | Reducción de las conductas autolesivas e autoestimuladoras disfuncionales em los Transtornos del Espectro del Autismo através de La terapia ocupacional | Pesquisa realizada com 20 crianças diagnosticadas com TEA realizando terapia ocupacional.                                                              |

Em relação ao ano de publicação, verificou-se um predomínio de trabalhos no ano de 2019 (38%; n=7) sendo encontrados (44,4%; n=8) na base de dados LILACS. Dentre os profissionais que participaram da publicação, em sua maioria foram fisioterapeutas, educadores físicos (38%; n=7), juntamente com psicólogos (38%; n=7).

Quadro 2: Aspectos dos estudos selecionados para composição da pesquisa

| N <sup>o</sup> | Autor (es)<br>Ano             | População do estudo                                                                                                                                                   | Base Periódicos                                   | País      |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1              | Corrêa et al.<br>2020.        | Foram utilizadas 41 Crianças diagnosticadas com TEA que praticavam exercícios aquáticos, aeróbicos, equitação, realidade virtual e exercícios de força e coordenação. | LILACS/ Revista brasileira de Ciência e Movimento | Brasil    |
| 2              | Balestro; Fernandes ;<br>2019 | Participaram dessa pesquisa cuidadores de 62 crianças com TEA no estado do Rio Grande do Sul.                                                                         | LILACS/ CoDAS                                     | Brasil    |
| 3              | Alejandra; Ekaine;<br>2020    | Grupos de no mínimo 60 crianças com autismo que experimentaram efeitos positivos da terapia ocupacional                                                               | LILACS/CurrMe dChem.                              | Argentina |
| 4              | Fessiaet al.<br>2018          | Aproximadamente 227 crianças que praticaram jogos individuais, natação, hidromassagem, equoterapia, bicicleta e caminhada.                                            | MEDLINE/ Revista de Salud Pública                 | Argentina |
| 5              | Rojas; Riviera; Nilo;<br>2019 | Pacientes pediátricos portadores de TEA no Chile.                                                                                                                     | MEDLINE/ Rev. Chil. Pediatr                       | Chile     |



|    |                                     |                                                                                                                                      |                                             |           |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 6  | Loyanoco; Ferreira; Iermoli. 2019   | Famílias de crianças portadoras de TEA na Argentina                                                                                  | MEDLINE/Arch ArgPediatr                     | Argentina |
| 7  | García; Solovieva; Rojas. 2020      | Criança de 6 anos e 11 meses                                                                                                         | LILACS/ Rev. Iberoam. Psicol. (Em linha)    | México    |
| 8  | Costa et al. 2021                   | 23 crianças de dois a 15 anos de idade com diagnóstico confirmado de TEA participantes do projeto "Corujas do Bem" em Catanduva, SP. | BDENF- Enfermagem/CuidArte, Enferm          | Brasil    |
| 9  | Rocha; Vasques; Lamônica (2019)     | Professores, pais e alunos de escolas que aplicavam diferentes instrumentos para ensino de crianças com TEA.                         | SciELO/ Rev. CEFAC                          | Brasil    |
| 10 | Magalhães et al. 2020               | Grupo de crianças com TEA atendidos por enfermeiros através de vários métodos de cuidados.                                           | SciELO/Enfermería Global                    | Brasil    |
| 11 | Gomes; Franzoni; Marinho. 2021      | 5 Crianças com TEA participantes do projeto Aqua Atividades em Florianópolis, Santa Catarina                                         | SciELO/Journal of Physical Education        | Brasil    |
| 12 | Díaz; Rodríguez; Bastías; 2021      | Grupo de 13 crianças entre 6-10 anos participantes de um programa de esportes em Madrid, Espanha.                                    | SciELO/Cuadernos de Investigación Educativa | Brasil    |
| 13 | Nascimento; Bitencourt; Fleig; 2021 | Aproximadamente 228 pacientes com TEA entre 2 a 22 anos de idade;                                                                    | SciELO/ Jornal Brasileiro de Psiquiatria    | Brasil    |
| 14 | Ramírez, et al. 2019                | Grupo de crianças com Paralisia Cerebral, TEA e Síndrome de Down.                                                                    | LILACS/ Rev. Chil. Nutr                     | Colômbia  |
| 15 | Nascimento, et al. 2018             | 10 enfermeiros efetivos de UBS com ESF em Maceió, Alagoas.                                                                           | BDENF – Enfermagem/ Rev. baianaenferm.      | Brasil    |
| 16 | Viana, et al. 2020                  | Aproximadamente 146 crianças com TEA.                                                                                                | LILACS/ Enferm. Foco                        | Brasil    |
| 17 | Vilar, et al. 2019                  | Aproximadamente 218 crianças portadoras de TEA.                                                                                      | LILACS/ Rev. baianaenferm                   | Brasil    |
| 18 | Torras; Más; 2019                   | 20 crianças diagnosticadas com TEA com pelo menos 3 meses de terapia ocupacional.                                                    | LILACS / Medicina (B. Aires)                | Espanha   |

A partir da análise dos dados, foi possível observar que os artigos 1, 4,



11 e 12 evidenciam a importância da realização de atividades físicas como abordagem complementar para o desenvolvimento motor das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Já os artigos 3 e 18 ressaltam a atuação da terapia ocupacional utilizando técnicas de integração sensorial com o intuito de trabalhar o desenvolvimento cognitivo e sensorial dessas crianças.

Os artigos 10 e 15 trazem um olhar sobre a importância da enfermagem como uma das principais áreas atuantes na realização do diagnóstico do autismo. Além de ter papel promotor de suporte aos pais e cuidadores, também é responsável por fazer acompanhamentos e encaminhamentos quando necessários. Apesar disso, salienta a necessidade de preparo na graduação para identificar os sinais e sintomas.

O artigo 14 discorre sobre os benefícios que o acompanhamento nutricional tem quando aplicados em crianças com alguma condição específica como o autismo. Os artigos 5, 7, 13, 16 e 17 vão salientar a importância da abordagem interdisciplinar no desenvolvimento e na qualidade de vida das crianças com TEA.

Os artigos 8 e 9 discorrem sobre a participação de pedagogos e de práticas utilizadas para trabalhar as disfunções cognitivas apresentadas nessa condição; e por fim, os artigos 2 e 17 demonstram a evolução na comunicação verbal e não verbal das crianças observadas pelos seus familiares e cuidadores (Tabela 2).

Tabela 3: Categorização do estudo conforme profissão, abordagem utilizada e importância da atuação

| Nº | Autor (es)<br>Ano      | Profissão                            | Abordagem utilizada                     | Importância da atuação                                                                           |
|----|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Corrêa et al.<br>2020. | Fisioterapeutas e educadores físicos | Exercícios aeróbicos de força, natação, | Melhora na diminuição de movimentos estereotipados;<br>Diminuição dos problemas comportamentais; |





|   |                                   |                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                   |                                                       | equitação, alongamentos, caminhadas e jogos com realidade virtual                                                 | Melhoras no desenvolvimento motor (equilíbrio, velocidade, agilidade, força muscular);<br>Melhora nos quadros de cognição e interação social;<br>Diminuição da ansiedade em situações de fobia.             |
| 2 | Balestro; Fernandes ; 2019        | Fonoaudiólogos                                        | Terapia fonoaudiológica.                                                                                          | Melhoras nas funções comunicativas interpessoais;<br>Aumento do uso do meio comunicativo vocal;<br>Melhoras nas funções comunicativas não interpessoais.                                                    |
| 3 | Alejandra; Ekaine; 2020           | Terapeuta ocupacional                                 | Integração sensorial e motora.                                                                                    | Melhorias na participação de atividades físicas, nas atividades de vida diária e a socialização.                                                                                                            |
| 4 | Fessiaet al. 2018                 | Educadores físicos e fisioterapeutas.                 | Natação, caminhada, equinoterapia, hidroginástica, jogos individuais orientados, corridas, bicicleta, musculação. | Desenvolvimento das habilidades motoras;<br>Melhor integração no contexto familiar e social;<br>Melhorias no comportamento e na atenção;<br>Inclusão de crianças autistas na prática de atividades físicas; |
| 5 | Rojas; Riviera; Nilo; 2019        | Professores, psicopedagogos e terapeutas ocupacionais | TEACCH, PRTySCERTS e intervenções sensoriais.                                                                     | Melhorias no desenvolvimento cognitivo e comportamental.<br>Melhora na capacidade de socialização.                                                                                                          |
| 6 | Loyanoco; Ferreira; Iermoli. 2019 | Clínicos gerais e pediatras.                          | Acompanhamento individualizado e puericultura.                                                                    | Diagnóstico precoce;<br>Intervenção precoce;<br>Melhoria na qualidade de vida dos pacientes.<br>Tratamento de sintomas e outras condições associados ao TEA.                                                |
| 7 | García; Solovieva; Rojas. 2020    | Psicólogos, professores.                              | Atividades sensoriais com diversas texturas, atividades físicas, jogos, atividades de vida diária.                | Desenvolvimento de habilidades motoras;<br>Desenvolvimento cognitivo.                                                                                                                                       |
| 8 | Costa et al. 2021                 | Professores e psicopedagogos                          | Métodos de ensino PECS e TEACCH.                                                                                  | Melhorias na capacidade de socialização, controle dos esfíncteres, coordenação motoras e concentração.                                                                                                      |





|    |                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diminuição de estereótipos, agitação, comportamentos inadequados.                                                |
| 9  | Rocha; Vasques; Lamônica (2019) | Professores.                        | <i>Acessible Literacy Learning(ALL), Promoting the Emergence of Advanced Knowledge(PEAK), Comprehensive Autism Program12 (CAP), 'Preschool Inventory of Repertoires for Kindergarten13 (PIRK), Collaborative Model for Promoting Competence and Success for Students with Autism Spectrum Disorder (COMPASS)</i> | Aprendizagem de fonemas;                                                                                         |
|    |                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melhoras positivas na linguagem receptiva dos alunos e nas habilidades;                                          |
|    |                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melhorias no desenvolvimento escolar, comportamento, comunicação, atividades de vida diária e integração social. |
| 10 | Magalhães et al. 2020           | Enfermeiros                         | Acompanhamento na puericultura, escuta qualificada e coordenação do cuidado.                                                                                                                                                                                                                                     | Diagnóstico precoce;                                                                                             |
|    |                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Orientações à família sobre o transtorno e os planos terapêuticos;                                               |
| 11 | Gomes; Franzoni; Marinho. 2021  | Educadores físicos, fisioterapeutas | Realização de atividades e brincadeiras como bolas, boias de diversos tipos, pranchas de stand up paddle, caiaques, remos, cesta de basquete flutuante                                                                                                                                                           | Progressão das habilidades sociais e na comunicação.                                                             |



|    |                                    |                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Díaz;Rodríguez;Bastías; 2021       | Psicólogos, educadores físicos e treinadores.    | Diversos tipos de jogos de esporte com ou sem bola.                                                                             | Aumento da prática de esportes por crianças com TEA;                                              |
| 13 | Nascimento;Bitencourt; Fleig; 2021 | Professores, educadores físicos, fisioterapeutas | Programa de Atenção aos Transtornos do Espectro (PAED), treinamento de Imitação Recíproca (RIT), atividades rítmicas, corridas. | Ganhos nas habilidades de imitação, ganho de linguagem e desenvolvimento social;                  |
|    |                                    |                                                  |                                                                                                                                 | Possibilita expressão corporal;                                                                   |
|    |                                    |                                                  |                                                                                                                                 | Melhorias nas habilidades sociais;                                                                |
| 14 | Ramírez, et al. 2019               | Nutricionista.                                   | Elaboração de dieta adequada as necessidades de cada paciente.                                                                  | Desenvolvimento da psicomotricidade, evolução na estabilidade de equilíbrio e coordenação motora. |
|    |                                    |                                                  |                                                                                                                                 | Diminuição de sintomas gastrointestinais;                                                         |
|    |                                    |                                                  |                                                                                                                                 | Melhorias dos sintomas presentes no TEA;                                                          |
|    |                                    |                                                  |                                                                                                                                 | Diminuição da recorrência de distúrbios alimentares;                                              |
| 15 | Nascimento, et al. 2018            | Enfermeiros.                                     | Acompanhamento do desenvolvimento através da puericultura.                                                                      | Suplementação alimentar conforme necessidade.                                                     |
|    |                                    |                                                  |                                                                                                                                 | Detecção precoce do TEA;                                                                          |
|    |                                    |                                                  |                                                                                                                                 | Apoio à criança e a família;                                                                      |
| 16 | Viana, et al. 2020                 | Enfermeiros, médicos, educadores físicos,        | Acompanhamento do desenvolvimento através da puericultura.                                                                      | Psicoeducação familiar;                                                                           |
|    |                                    |                                                  |                                                                                                                                 | Coordenação do cuidado.                                                                           |
|    |                                    |                                                  |                                                                                                                                 | Diagnóstico precoce;                                                                              |
| 17 | Vilar, et al. 2019.                | Fonoaudiólogos, professores, psicopedagogos.     | Terapia fonoaudiológica; brincadeiras.                                                                                          | Melhorias dos sintomas associados ao autismo;                                                     |
|    |                                    |                                                  |                                                                                                                                 | Melhoras na coordenação motora e capacidade cognitiva.                                            |
|    |                                    |                                                  |                                                                                                                                 | Melhorias no desempenho verbal e aumento do vocabulário;                                          |
| 17 |                                    |                                                  |                                                                                                                                 | Melhorias nas expressões faciais e gestuais;                                                      |
|    |                                    |                                                  |                                                                                                                                 | Melhorias nas habilidades sociais.                                                                |



|    |                         |                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|----|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Torras;<br>Más;<br>2019 | Terapeutas<br>ocupacionais,<br>médicos. | Tratamento<br>dos sintomas<br>com<br>medicações,<br>mudanças<br>ambientais,<br>terapia<br>cognitiva-<br>comportament<br>al, terapia de<br>integração<br>sensorial. | Diminuição dos movimentos<br>estereotipados;                                       |
|    |                         |                                         |                                                                                                                                                                    | Melhora dos sintomas do TEA e<br>de condições associadas;                          |
|    |                         |                                         |                                                                                                                                                                    | Melhorias no comportamento,<br>desenvolvimento de habilidades<br>sociais, motoras. |

#### 4. Discussão

A identificação do autismo ocorre na maioria das vezes tardiamente e um dos principais motivos é o *déficit* na capacitação dos profissionais de saúde para identificar os sinais e sintomas iniciais (VIANA *et al.*, 2020). O diagnóstico pode ser realizado através da anamnese em crianças maiores, investigando alterações no neurodesenvolvimento, na comunicação e habilidades sociais além de observação de comportamentos restritivos. Esse deve ser feito com uma equipe multidisciplinar incluindo neurologistas e/ou neuropediatras, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais (ROJAS; RIVERA; NILO; 2019). De forma parceira também deve ser feito o tratamento (VIANA *et al.*, 2020).

O atendimento multiprofissional é muito importante para o desenvolvimento do paciente com transtorno do espectro autista notadamente observado desde o diagnóstico ao processo de tratamento demonstrado pelos avanços no desenvolvimento da linguagem, autonomia, adaptação sensorial, aprendizado cognitivo, comportamental, reabilitação motora, interação social e comunicacional (BEZERRA; RUIZ; 2018)

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem como um dos objetivos fazer o acompanhamento das crianças na puericultura. No processo de monitorar o crescimento e desenvolvimento, o enfermeiro é responsável por avaliar e detectar qualquer sinal indicativo de anormalidades para



diagnóstico precoce principalmente no que tange o TEA, bem como dá suporte à família/cuidadores dessa criança. Após diagnóstico, a enfermagem pode atuar na psicoeducação familiar, no acompanhamento aos retornos e quando necessário, no encaminhamento a outras especialidades (NASCIMENTO *et al.*, 2018).

Através de um olhar cuidadoso, atento às necessidades do paciente e escuta qualificada, torna-se um elo importante da equipe multiprofissional e os cuidadores do infante (MAGALHÃES *et al.*, 2020). O enfermeiro pode utilizar de instrumentos para rastreio de indicadores clínicos, tais como: IRDI (Indicadores Clínicos de Risco para o Desenvolvimento) e o M-Chat (*Modifed Checklist for Autismo in Toddlers*) (ARAUJO *et al.*, 2019).

O papel do médico clínico e/ou pediatra tem como premissa não somente o diagnóstico, mas também assumir uma atitude de liderança da equipe multiprofissional com o objetivo de melhorar a qualidade de vida no TEA. Outro ponto importante é a prevenção e tratamento de condições que costumam estarem associadas, assim como na abordagem farmacológica quando se faz necessário (LOYACONO; FERREIRA; LERMOLI; 2019).

O tratamento para o TEA consiste na abordagem multiprofissional, envolvendo cuidados das diversas áreas da saúde, incluindo o tratamento farmacológico convencional. Os fármacos que fazem parte do tratamento têm como finalidade agir sob os sintomas relacionados a agitação psicomotora e irritabilidade, sendo estes o aripiprazol e a risperidona. Além do uso desses fármacos, existem as práticas complementares que proporcionam a integração dos pacientes produzindo avanços nas respostas motoras e comportamental (VIANA *et al.*, 2020).

A prática do modelo ASI (*Ayres SensoryIntegration*) é um modelo de terapia ocupacional muito utilizada para tratar as diferenças sensoriais em pessoas com transtorno do espectro autista. Ela é aplicada com o objetivo de abordar os déficits sensoriais táteis, proprioceptivos e/ou vestibulares estimulando a participação ativa em atividades físicas, sociais e funcionais,



repletas de experiências sensoriais e individualizadas (ALEJANDRA; RODRÍGUEZ; 2020). Portanto, por meio de técnicas de habitualização e sensibilização, enriquecidas com avanços científicos sobre o processamento e o estado que alerta, percebe-se que resultados muito positivos estão sendo obtidos em termos de redução de comportamento autoestimulantes e autolesivos (MAPURUNGA *et al.*, 2021).

O modelo *TEACCH* (*Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children*) estuda a compreensão, a forma de aprender, pensar e experimentar dos autistas principalmente aqueles que possuem dificuldades comunicativas. (FERRER; SOLOVIEVA; ROJAS; 2020). Os professores e psicopedagogos principalmente criam um ambiente que tem por finalidade desenvolver habilidades educacionais que compensem o déficit de comunicação dos seus alunos (COSTA, *et al.* 2021).

Instrumentos de intervenção curricular como *Acessible Literacy Learning (ALL)*, *Promoting the Emergence of Advanced Knowledge (PEAL)*, *Comprehensive Autism Program (CAP)*, *Preschool Inventory of Repertoires for Kindeergarten (PIRK)* foram criados para aplicação com escolares com TEA a fim de melhorar o desempenho cognitivo, nos comportamentos, linguagem, comunicação e socialização além de habilidades de vida diária (ROCHA; VASQUES; LAMÔNICA; 2019).

A prática de atividades físicas é importante para o desenvolvimento físico de todas as crianças, e na criança com transtorno do espectro autista, tem um papel fundamental na terapêutica desses infantes. Elas são indicadas, pois contribuem no aperfeiçoamento de habilidades importantes e que podem ser afetadas pela disfunção causada pelo transtorno (CORRÊA *et al.*, 2020). Diversos estudos mostraram resultados significativos de práticas como atividades aquáticas, equitação, artes marciais, corrida e outros, na aquisição e aprimoramento de habilidades e capacidades físicas e motoras, de função executiva e psicossociais e diminuição de comportamentos disfuncionais (PEREIRA; FREITAS; 2021)





Uma das principais alterações é a motora, que ocorrem por disfunções nos padrões de sulcamento cortical nos lobos frontais e temporais, alterações no cerebelo, hipocampo, corpo caloso e amígdalas, todos estes responsáveis por processar informações motoras. As crianças autistas apresentam alterações de percepção que afetarão na seletividade sobre o que é importante, prejudicando sua função motora (CORRÊA *et al.*, 2020).

Além dos aspectos motores, a realização de atividades físicas programadas também impacta positivamente nos contextos emocionais e comportamentais. Através de estimulações adequadas, as crianças autistas podem alcançar os mesmos comportamentos que as demais crianças (FESSI *et al.*, 2018).

O fisioterapeuta e o educador físico têm uma importante atuação no acompanhamento dessas crianças. A criança portadora de TEA pode exibir um comportamento repetitivo que tem sido reduzido através da realização de atividades físicas. Além disso, essas crianças têm propensão a apresentarem movimentos estereotipados que tem demonstrado através do acompanhamento físico, melhoras consideráveis no desenvolvimento dos pacientes (CORRÊA *et al.*, 2020). A prática da terapia psicomotora abrange aspectos que relacione o indivíduo aos sentimentos, traumas e sua ligação à expressão através do corpo, fazendo com que o indivíduo relaxe e trabalhe o sentimento de forma que realize um trabalho de controle de sentimento auxiliando na socialização. A Fisioterapia pode atuar na criança com Transtorno do Espectro Autista na ativação dos níveis sensorial e motor, buscando melhorar a concentração, a memória e as habilidades motoras, como a coordenação e o equilíbrio (OLIVEIRA *et al.*, 2019).

No que se refere ao desenvolvimento comunicativos dessas crianças, há alterações na habilidade de comunicação funcional verbal e não-verbal. A avaliação da competência comunicativa delas incluem uma compreensão clara do ambiente em que está inserida e como esta usa suas habilidades lingüísticas. Através da orientação fonoaudiológica, é indicado pelos





cuidadores melhora nas habilidades comunicacionais interpessoais como gestos; uso do meio vocal; e da linguagem verbal tanto as relações interpessoais quanto não interpessoais. Além disso, também pode-se observar flexibilizações nos usos dos meios e das funções comunicativas (BALESTRO; FERNANDES; 2019).

A abordagem nutricional é outro método que pode contribuir para a qualidade de vida de indivíduos com TEA. E as contribuições se devem ao fato de haver alterações gastrointestinais e comportamental frente a alimentação, como transtornos alimentares. Essas crianças tendem a preferir alimentos industrializados e preterirem frutas e verduras o que causa prejuízos nutricionais. É observado o consumo inadequado de diversas substâncias essenciais para o funcionamento do organismo como o Cálcio, Ferro, Ácido fólico, vitamina C, Magnésio, Ácidos graxos essenciais, entre outros, tornando-se necessário um acompanhamento profissional nutricional, com uma dieta controlada limitando o consumo de carboidratos e proteínas, afim de corrigir as deficiências nutricionais e reduzir os sintomas e comorbidades associados ao TEA (RAMÍREZ *et al*,. 2019).

## **5. Conclusão**

Conclui-se que a abordagem multiprofissional no TEA tem implicações sobre o melhor prognóstico e consequente desenvolvimento positivo do indivíduo com a condição clínica. Portanto, as várias profissões têm importância no diagnóstico e tratamento das crianças portadoras do TEA, corroborando com a autonomia e qualidade de vida para um desenvolvimento pleno de suas habilidades físicas, psicológicas, comportamentais e de comunicação.



## Referências

GOMES, Paulyane T.M.; LIMA, Leonardo H.L.; BUENO, Mayza K.G.; ARAÚJO, Liubiana A.; SOUZA, Nathan M..Autism in Brazil: a systematic review of family challenges and coping strategies. **Jornal de Pediatria**, [S.L.], v. 91, n. 2, p. 111-121, mar. 2015. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jped.2014.08.009>.

COSTA, Gabriela Cristina de Paula. Influência dos métodos de ensino PECS e TEACCH sobre o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com transtorno do espectro autista. **Cuidarte Enfermagem**, Catanduva, v. 1, n. 15, p. 22-28, jun. 2021.

HALPERN, Cristina Martins. A Perturbação do Espectro do Autismo na Primeira Infância: O Modelo do Centro de Estudos do Bebê e da Criança de Avaliação Diagnóstica e Intervenção Terapêutica. **Revista Científica da Ordem dos Médicos**, Portugal, v. 10, n. 34, p. 657-663, out. 2021.

Estrada PF, Tavares C. Mutações de novo no gene DEAF1 e sua relação com o autismo: estudo de caso. **REVISA**. 2021; 10(2): 347-57. Doi: <https://doi.org/10.36239/revisa.v10.n2.p347a357>

SINISCALCO, Dario. Stem cell therapy in autism: recent insights. **Dovepress**. Inglaterra, p. 55-67. out. 2018.

ORO, A. Bravo; BRISEÑO, J. Vázquez; GARCÍA, C.A. Cuello; SEPÖLVEDA, R.F. Calderón; VILLALOBOS, A.M. Hernández; SÁNCHEZ, C. Esmer. Manifestaciones iniciales de los trastornos del espectro autista. Experiencia en 393 casos atendidos en un centro neurológico infantil. **Neurología**, [S.L.], v. 27, n. 7, p. 414-420, set. 2012. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2011.09.011>.

FONSECA, Larissa Kathlem Rodrigues. Influências do transtorno do espectro autista nas relações familiares: revisão sistemática. **Revista Baiana de Saúde Pública**, Salvador, v. 2, n. 43, p. 444-465, abr. 2019.

ARAÚJO, Cássio Monteiro de. O papel do enfermeiro na assistência à criança autista. **Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde**, Distrito Federal, v. 3, n. 1, p. 31-35, jan. 2019.

Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de orientação: Transtorno do Espectro do Autismo. Porto Alegre: SBP, 2019.



AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V). Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2013.

SEIZE, Mariana de Miranda; BORSA, Juliane Callegaro. Instrumentos para Rastreamento de Sinais Precoces do Autismo: revisão sistemática. **Psico-Usf**, [S.L.], v. 22, n. 1, p. 161-176, abr. 2017. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1413-82712017220114>.

OLIVEIRA, Érica Monteiro; GONÇALVES, Francisca Tatiana Dourado; MAGALHÃES, Marcio Marinho; NASCIMENTO, Helena Morgana Sousa do; CARVALHO, Izabel Cristina Vale de; LEMOS, Ana Valéria Lopes; SAID, Érika Castelo Branco; CUNHA, Maria de Jesus Martins de Andrade Silva; ARAÚJO, Zaira Arthemisa Mesquita; CONCEIÇÃO, Pedro Wilson Ramos da. O impacto da Psicomotricidade no tratamento de crianças com transtorno do Espectro Autista: revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [S.L.], n. 34, p. 1-7, 23 out. 2019. Revista Eletronica Acervo Saude. <http://dx.doi.org/10.25248/reas.e1369.2019>.

JORGE, Renata Pessoa Chein; PAULA, Fernanda Mendes; SILVÉRIO, Giovana Barreto; MELO, Letícia de Araújo; FELÍCIO, Paulo Vitor Pina; BRAGA, Talita. Diagnóstico de autismo infantil e suas repercussões nas relações familiares e educacionais. **Brazilian Journal Of Health Review**, [S.L.], v. 2, n. 6, p. 5065-5077, 2019. Brazilian Journal of Health Review. <http://dx.doi.org/10.34119/bjhrv2n6-015>.

ARAÚJO, Neuma Apinagé. A musicoterapia no tratamento de crianças com autismo: revisão integrativa. **Ciência e Saberes**, Grajaú, v. 2, n. 4, p. 1002-1006, jun. 2018.

CONSOLINI, Marília; LOPES, Ederaldo José; LOPES, Renata Ferrarez Fernandes. Terapia Cognitivo-comportamental no Espectro Autista de Alto Funcionamento: revisão integrativa. **Rev. bras. ter. cogn.**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 38-50, jun. 2019. Disponível em <[http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1808-56872019000100007&lng=pt&nrm=iso](http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-56872019000100007&lng=pt&nrm=iso)>. acessos em 11 nov. 2021. <http://dx.doi.org/10.5935/1808-5687.20190007>.

Reis, S. T., & Lenza, N. (2019). A Importância de um diagnóstico precoce do autismo para um tratamento mais eficaz: uma revisão da literatura. *Revista Atenas Higeia*, 2(1), 1 - 7. Recuperado de <http://atenas.edu.br/revista/index.php/higeia/article/view/19>



MAPURUNGA, B. A.; MENDES, A. L. R.; SILVEIRA, V. B.; CORREIA, R. F. DE O.; CARVALHO, A. F. M. DE. A atuação do terapeuta ocupacional na reabilitação de pessoas com autismo. **Revista de Casos e Consultoria**, v. 12, n. 1, p. e26291, 17 set. 2021.

VIANA, Ana Clara Vieira. Autismo: uma revisão integrativa. **Revista Saúde Dinâmica**, Vale do Piranga, v. 2, n. 3, p. 1-18, nov. 2020.

PEREIRA, F. S.; FREITAS, J. F. F. DE. ATIVIDADE FÍSICA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO DE PERIÓDICOS BRASILEIROS. **Cenas Educacionais**, v. 4, p. e11933, 13 set. 2021.

BOTELHO, L. L. R.; CUNHA, C. C. de A.; MACEDO, M. O MÉTODO DA REVISÃO INTEGRATIVA NOS ESTUDOS ORGANIZACIONAIS. **Gestão e Sociedade**, [S. l.], v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011. DOI: 10.21171/ges.v5i11.1220. Disponível em: <https://www.gestaoesociedade.org/gestaoesociedade/article/view/1220>. Acesso em: 24 nov. 2021.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein (São Paulo)**. São Paulo, V. 8, n. 1, p. 102-106, mar. 2010. <https://doi.org/10.1590/s1679-45082010rw1134>

CORRÊA VP, GONZALES AI, BESEN E, MOREIRA E, DA CUNHA J, PAIVAKM, HAAS P. Impacto do exercício físico no transtorno do espectro autista: uma revisão sistemática. *R. bras. Ci. e Mov* 2020;28(2):89-99.

Loyacono N, Ferreira ML, Iermoli R. Humanism in medicine. The critical role of pediatricians in autism spectrum disorder. *Arch Argent Pediatr* 2019;117(3):195-197

ABELENDA, Alejandra J; RODRIGUEZ ARMENDARIZ, Ekaine. Evidencia científica de integración sensorial como abordaje de terapia ocupacional en autismo. **Medicina (B. Aires)**, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, v. 80, supl. 2, p. 41-46, marzo 2020. Disponible en <[http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0025-76802020000200010&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802020000200010&lng=es&nrm=iso)>. accedido en 28 enero 2022.

ROJAS, Valeria; RIVERA, Andrea; NILO, Nelson. Actualización en diagnóstico e intervención temprana del Trastorno del Espectro Autista. **Rev. chil. pediatr.**, Santiago, v. 90, n. 5, p. 478-484, out. 2019. Disponível em <[http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0370-41062019000500478&lng=pt&nrm=iso](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062019000500478&lng=pt&nrm=iso)>. acessos em 28 jan. 2022. <http://dx.doi.org/10.32641/rchped.v90i5.1294>.

Balestro, Juliana Izidro e Fernandes, Fernanda Dreux Miranda Percepção de cuidadores de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo quanto ao





perfil comunicativo de seus filhos após um programa de orientação fonoaudiológica. CoDAS [online]. 2019, v. 31, n. 1 [Acessado 28 Janeiro 2022] , e20170222. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2317-1782/20182018222>>. Epub 07 Mar 2019. ISSN 2317-1782. <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20182018222>.

FESSIA, Gabriel et al . Estrategias de actividad física planificada en autismo: revisión sistemática. **Rev. salud pública**, Bogotá , v. 20, n. 3, p. 390-395, June 2018

. Available from <[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0124-00642018000300390&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642018000300390&lng=en&nrm=iso)>.

accession 28 Jan. 2022. <https://doi.org/10.15446/rsap.v20n3.63040>

Nascimento YCML, Castro CSC, Lima JLR, Albuquerque MCS, Bezerra DG. Transtorno do espectro

autista: detecção precoce pelo enfermeiro na Estratégia Saúde da Família. Rev baiana enferm. 2018;32:e25425.

VIANA, ÁDRIA et al. Práticas complementares ao transtorno do espectro autista infantil: revisão integrativa da literatura. **Enferm. Foco (Brasília)**.2020;

García Escárpita Ferrer, C. R., Solovieva, Y. & Quintanar Rojas, L. (2020). Evaluación e intervención Neuropsicológica en un caso de Trastorno del Espectro Autista (TEA) severo. Revista Iberoamericana de Psicología , 13 (2), 99-111. Obtenido de:

<https://reviberopsicologia.iberro.edu.co/article/view/1583>

Nova versão da Caderneta da Criança será enviada para todo o Brasil. Gov. BR, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/janeiro/nova-versao-da-caderneta-da-crianca-sera-enviada-para-todo-o-brasil>. Acesso em: 30, janeiro de 2022.

PEREIRA, F. S.; FREITAS, J. F. F. DE. ATIVIDADE FÍSICA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO DE PERIÓDICOS BRASILEIROS. Cenas Educacionais, v. 4, p. e11933, 13 set. 2021.

MAPURUNGA, B. A.; MENDES, A. L. R.; SILVEIRA, V. B.; CORREIA, R. F. DE O.; CARVALHO, A. F. M. DE. A atuação do terapeuta ocupacional na reabilitação de pessoas com autismo. Revista de Casos e Consultoria, v. 12, n. 1, p. e26291, 17 set. 2021.

OLIVEIRA, Érica Monteiro; GONÇALVES, Francisca Tatiana Dourado; MAGALHÃES, Marcio Marinho; NASCIMENTO, Helena Morgana Sousa do; CARVALHO, Izabel Cristina Vale de; LEMOS, Ana Valéria Lopes; SAID, Érika Castelo Branco; CUNHA, Maria de Jesus Martins de Andrade Silva; ARAUJO, Zaira Arthemisa Mesquita; CONCEIÇÃO, Pedro Wilson Ramos da. O impacto da Psicomotricidade no tratamento de crianças com transtorno do Espectro Autista: revisão integrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde, [S.L.], n. 34, p. 1-7, 23 out. 2019. Revista Eletronica Acervo Saude. <http://dx.doi.org/10.25248/reas.e1369.2019>.





ARAUJO, Cássio Monteiro de. O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA AUTISTA. *Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde, Distrito Federal*, v. 3, n. 1, p. 31-35, jan. 2019.

BEZERRA, Gabrielle Sarah da Silva; RUIZ, Erasmo Missea. DIFICULDADES NO ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DE PESSOAS COM AUTISMO. *In: FROTA, Francisco Horácio da Silva et al. DIREITO E CIDADANIA*. Fortaleza: EDMETA, 2018. cap. 1, p. 55-68.